



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN
INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Insiden Keselamatan Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat dilaporkan kepada Pemilik Rumah Sakit Prima Husada Malang. Seperti yang kita pahami bahwa nafas dari *Patient Safety* adalah belajar (*learning*) dari KTD yang terjadi untuk selanjutnya disusun langkah-langkah agar kejadian serupa tidak akan terulang Kembali, baik di tempat/unit yang sama maupun di tempat/unit yang lain di Rumah Sakit Prima Husada, sehingga dapat meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien.

Salah satu program utama dalam penerapan Keselamatan Pasien adalah pelaporan Insiden Keselamatan Pasien. Pelaporan ini akan menggerakkan berbagai proses lanjutan seperti analisis terhadap Insiden dan akibat-akibatnya, penemuan berbagai penyebab, solusinya, dan implementasi. Pelaporan insiden dan proses-proses lanjutan tersebut merupakan jawaban yang paling tepat terhadap keberadaan KTD / KNC / KTC / KPC / Sentinel, sehingga diharapkan kejadian ini dapat ditekan, dan lebih utama lagi terlaksananya asuhan pasien yang lebih aman.

Dengan tersusunya Laporan Insiden Keselamatan Pasien ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistematis dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi Rumah Sakit Prima Husada adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi Rumah Sakit Prima Husada tersebut, maka didukung oleh 3 misi sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, akurat. 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien. 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Dalam upaya memberikan pelayanan berkualitas prima yang mengedepankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar Akreditasi RS Kemenkes (STARKES). Kegiatan ini dilakukan di setiap unit terkait untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Salah satu program utama dalam penerapan Keselamatan Pasien adalah pelaporan Insiden Keselamatan Pasien. Pelaporan ini akan menggerakkan berbagai proses lanjutan seperti analisis terhadap Insiden dan akibat-akibatnya, penemuan berbagai penyebab, solusinya, dan implementasi. Pelaporan insiden dan proses-proses lanjutan tersebut merupakan jawaban yang paling tepat terhadap keberadaan KTD / KNC / KTC / KPC / Sentinel, sehingga diharapkan insiden ini ditekan, dan lebih utama lagi terlaksananya asuhan pasien yang lebih aman.

Laporan Insiden Keselamatan pasien ini dibuat agar kejadian serupa tidak akan terulang Kembali, baik di tempat/unit yang sama maupun di tempat/unit yang lain di Rumah Sakit Prima Husada, sehingga dapat meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum

- a. Menurunnya Insiden Keselamatan pasien (KTD, KNC, KTC, dan KPC serta sentinel)
- b. Meningkatnya mutu pelayanan dan Keselamatan pasien

Tujuan Khusus

- a. Terlaksananya sistem pelaporan dan pencatatan insiden keselamatan pasien rumah sakit.
- b. Diketahui penyebab Insiden keselamatan pasien sampai pada akar masalah.
- c. Didapatkan pembelajaran untuk perbaikan asuhan kepada pasien agar dapat mencegah kejadian yang sama dikemudian hari.

BAB II
PELAPORAN INSIDEN

2.1 Jumlah Ketidaksesuaian Diagnosis Praoperasi dan Pasca Operasi pada Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Operasi	Jumlah Ketidaksesuaian
1	Januari	366	0
2	Februari	337	0
3	Maret	364	0
4	April	417	0
5	Mei	373	0
6	Juni	376	0
7	Juli	444	0
8	Agustus	412	0
9	September	395	0
10	Oktober	397	0
11	November	424	0
12	Desember	433	0

Kesimpulan:
Berdasarkan data jumlah ketidaksesuaian antara diagnosis praoperasi dan pascaoperasi pada bulan Januari hingga Desember tahun 2025 tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian.

2.2 Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Berdasarkan Kejadian Reaksi Transfusi

No	Bulan	Jumlah Transfusi	Jumlah Reaksi Transfusi
1	Januari		0
2	Februari		0
3	Maret		0
4	April		0
5	Mei		0
6	Juni		0
7	Juli		0
8	Agustus		0
9	September		0
10	Oktober		0
11	November		0
12	Desember		0

Kesimpulan:**Analisis:**

- Tidak terdapat kejadian reaksi transfusi selama periode Januari hingga Desember
- Hal ini menunjukkan bahwa proses transfusi darah di fasilitas layanan telah dilakukan dengan baik, sesuai prosedur, dan minim risiko.
- Namun, tidak adanya laporan reaksi bukan berarti risiko tidak ada. Ada kemungkinan kejadian ringan tidak terdokumentasi atau tidak dikenali sebagai reaksi transfusi.

Rekomendasi:

- **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi**
Lakukan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan tentang identifikasi dan pelaporan reaksi transfusi, termasuk yang ringan
- **Audit dan Monitoring Berkala**
Lakukan audit klinis berkala terhadap prosedur transfusi dan dokumentasi efek samping untuk memastikan kepatuhan.
- **Evaluasi Pre-Transfusi dan Monitoring Ketat Post-Transfusi**
Pastikan semua pasien yang mendapat transfusi dimonitor selama dan setelah transfusi sesuai standar.

2.3 Jumlah Insiden Keselamatan Pasien (IKP) yang dilaporkan ke Komite PMKP Pada Tahun 2025

Januari

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	8/1/2025	Pasien dengan kunjungan berulang ke IGD tetapi tidak segera di rawat inapkan	KTC	Dokter IGD harus lebih peka dan tidak boleh meremehkan pasien, jika pasien datang berulang dengan keluhan yang sama, segera konsulkan ke DPJP.
2	10/1/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell
3	13/1/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Segera melaporkan pada IPSRS atau Tim IT
4	13/1/2025	Lantai basah area ruang tunggu rawat jalan	KPC	segera melaporkan pada tim CS
5	16/1/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
6	21/01/2025	Tampon tertinggal karena operan tidak segera dilaksanakan dan dioperkan kembali tanpa melakukan crosscek	KTC	perawat sebaiknya segera melakukan advice DPJP jika masih ada waktu sebelum shift berakhir. Karena operan yang berulang akan berisiko advice tidak dijalankan apalagi jika tidak dilakukan crosscek
7	23/01/2025	Lantai basah area ruang tunggu farmasi	KPC	segera melaporkan pada tim CS
8	24/01/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
9	24/01/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
10	24/01/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell

Februari

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	2/2/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
2	6/2/2025	Pasien tidak mendapatkan makan	KPC	Melakukan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan untuk mengingatkan seluruh kepala ruangan dan perawat supaya meluangkan waktu ketika penyaji melakukan update saat membagikan makan.
3	8/2/2025	Lantai basah tetapi tidak ada tanda risiko jatuh	KPC	segera melaporkan pada tim CS
4	18/2/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
5	22/02/2025	Lantai basah di ruang tunggu IGD	KPC	segera melaporkan pada tim CS
6	25/02/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
7	27/02/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP

Maret

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	3/3/2025	Kesalahan penyiapan obat	KNC	Meningkatkan fokus dan ketelitian saat bekerja, melakukan double cek saat menyiapkan obat
2	4/3/2025	Lantai basah tetapi tidak ada tanda risiko jatuh	KPC	segera melaporkan pada tim CS
3	6/3/2025	Kesalahan input e-resep	KTC	Jalin komunikasi baik dengan dokter penulis resep untuk mengingatkan DPJP, Apoteker wajib melakukan skrining dan verifikasi resep elektronik secara teliti.
4	7/3/2025	Kesalahan input e-resep	KTC	Jalin komunikasi baik dengan dokter penulis resep untuk mengingatkan DPJP, Apoteker wajib melakukan skrining dan verifikasi resep elektronik secara teliti.
5	11/3/2025	Kesalahan penulisan e-tiket	KTC	Jalin komunikasi baik dengan dokter penulis resep untuk mengingatkan DPJP, Apoteker wajib melakukan skrining dan verifikasi resep elektronik secara teliti.
6	14/3/2025	Kesalahan penulisan e-tiket	KTC	Jalin komunikasi baik dengan dokter penulis resep untuk mengingatkan DPJP, Apoteker wajib melakukan skrining dan verifikasi resep elektronik secara teliti.
7	19/03/2025	Kesalahan pemberian obat	KTC	Identifikasi Pasien: Pastikan nama pasien benar setiap kali obat diberikan (Benar Pasien). Verifikasi Resep: Periksa ulang resep, termasuk nama, alamat, dan detail obat (Benar Obat, Dosis, Cara, Waktu).
8	11/3/2025	Kesalahan pemberian diet	KTC	Meningkatkan konsentrasi saat bekerja, Melakukan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan untuk mengingatkan seluruh kepala ruangan dan perawat supaya meluangkan waktu ketika penyaji melakukan update saat membagikan makan.
9	11/3/2025	Kesalahan pemberian diet	KTC	Meningkatkan konsentrasi saat bekerja, Melakukan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan untuk mengingatkan seluruh kepala ruangan

				dan perawat supaya meluangkan waktu ketika penyaji melakukan update saat membagikan makan.
10	4/3/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
11	7/3/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
12	11/3/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
13	19/3/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
14	22/3/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
15	24/3/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
16	25/3/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
17	28/3/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
18	29/3/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP

April

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	4/4/2025	Lantai basah tetapi tidak ada tanda risiko jatuh	KPC	segera melaporkan pada tim CS
2	8/4/2025	Kesalahan pemberian diet	KTC	Meningkatkan konsentrasi saat bekerja, Melakukan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan untuk mengingatkan seluruh kepala ruangan dan perawat supaya meluangkan waktu ketika penyaji melakukan update saat membagikan makan.
3	14/4/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
4	17/4/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell
5	24/4/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Segera melaporkan pada IPSRS atau Tim IT
6	26/4/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
7	27/4/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
8	28/4/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
9	29/4/2025	Lantai basah tetapi tidak ada tanda risiko jatuh	KPC	segera melaporkan pada tim CS

Mei

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	2/5/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell
2	4/5/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Segera melaporkan pada IPSRS atau Tim IT
3	6/5/2025	Kesalahan pemberian diet	KTC	Meningkatkan konsentrasi saat bekerja, Melakukan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan untuk mengingatkan seluruh kepala ruangan dan perawat supaya meluangkan waktu ketika penyaji melakukan update saat membagikan makan.
4	10/5/2025	Lantai basah tetapi tidak ada tanda risiko jatuh	KPC	segera melaporkan pada tim CS
5	11/5/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
6	12/5/2025	Lantai basah di ruang tunggu IGD	KPC	segera melaporkan pada tim CS
7	15/5/2025	Kesalahan penyiapan obat	KNC	Meningkatkan fokus dan ketelitian saat bekerja, melakukan double cek saat menyiapkan obat
8	15/5/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
9	17/5/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
10	19/9/2025	Kesalahan pemberian obat	KTC	Identifikasi Pasien: Pastikan nama pasien benar setiap kali obat diberikan (Benar Pasien). Verifikasi Resep: Periksa ulang resep, termasuk nama, alamat, dan detail obat (Benar Obat, Dosis, Cara, Waktu).

11	20/5/2025	Kesalahan penulisan e-tiket	KTC	Jalin komunikasi baik dengan dokter penulis resep untuk mengingatkan DPJP, Apoteker wajib melakukan skrining dan verifikasi resep elektronik secara teliti.
12	21/5/2025	Kesalahan pemberian obat	KTC	Identifikasi Pasien: Pastikan nama pasien benar setiap kali obat diberikan (Benar Pasien). Verifikasi Resep: Periksa ulang resep, termasuk nama, alamat, dan detail obat (Benar Obat, Dosis, Cara, Waktu).
13	22/5/2025	Kesalahan pemberian diet	KTC	Meningkatkan konsentrasi saat bekerja, Melakukan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan untuk mengingatkan seluruh kepala ruangan dan perawat supaya meluangkan waktu ketika penyaji melakukan update saat membagikan makan.
14	28/5/2025	Kesalahan pemberian obat	KTC	Identifikasi Pasien: Pastikan nama pasien benar setiap kali obat diberikan (Benar Pasien). Verifikasi Resep: Periksa ulang resep, termasuk nama, alamat, dan detail obat (Benar Obat, Dosis, Cara, Waktu).

Juni

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	4/6/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell
2	7/6/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Segera melaporkan pada IPSRS atau Tim IT
3	8/6/2025	Kesalahan pemberian obat	KTC	Identifikasi Pasien: Pastikan nama pasien benar setiap kali obat diberikan (Benar Pasien). Verifikasi Resep: Periksa ulang resep, termasuk nama, alamat, dan detail obat (Benar Obat, Dosis, Cara, Waktu).
4	11/6/2025	Lantai basah tetapi tidak ada tanda risiko jatuh	KPC	segera melaporkan pada tim CS
5	14/6/2026	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
6	21/6/2026	Lantai basah di ruang tunggu IGD	KPC	segera melaporkan pada tim CS
7	22/6/2026	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP

Juli

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	2/7/2025	Kesalahan penyiapan obat	KNC	Meningkatkan fokus dan ketelitian saat bekerja, melakukan double cek saat menyiapkan obat
2	4/7/2025	Lantai basah tetapi tidak ada tanda risiko jatuh	KPC	segera melaporkan pada tim CS
3	5/7/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell
4	5/7/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Segera melaporkan pada IPSRS atau Tim IT
5	7/7/2025	perawat lupa melakukan advice untuk melepas kateter	KTD	perawat sebaiknya segera melakukan advice DPJP jika masih ada waktu sebelum shift berakhir. Karena operan yang berulang akan berisiko advice tidak dijalankan apalagi jika tidak dilakukan crosscek
6	4/7/2025	perawat salah memberi terapi	KTC	perawat harus memastikan dan melakukan double cek sebelum memberikan terapi pada pasien, menjalankan SPO pemberian obat
7	23/7/2025	Terjadi perdarahan saat melepas kateter	KTD	Perhatikan SPO pemasangan kateter, pastikan tindakan sesuai dengan SPO, agenda pelatihan pemasangan SPO
8	16/7/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell
9	19/7/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Segera melaporkan pada IPSRS atau Tim IT
10	22/7/2025	Lantai basah area ruang tunggu rawat jalan	KPC	segera melaporkan pada tim CS
11	24/7/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP

12	25/7/2025	Kesalahan input e-resep	KTC	Jalin komunikasi baik dengan dokter penulis resep untuk mengingatkan DPJP, Apoteker wajib melakukan skrining dan verifikasi resep elektronik secara teliti.
13	26/7/2025	Kesalahan penulisan e-tiket	KTC	Jalin komunikasi baik dengan dokter penulis resep untuk mengingatkan DPJP, Apoteker wajib melakukan skrining dan verifikasi resep elektronik secara teliti.
14	28/7/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
15	29/7/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
16	30/9/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP

Agustus

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	13/8/2025	salah diagnosis kegawatan	KTD	Dokter IGD harus mampu melakukan pengkajian dan pemeriksaan secara menyeluruh supaya dapat menentukan diagnosa dan menetapkan DPJP dengan sesuai.
2	16/8/2025	pasien ICU di letakkan di ruang biasa, EWS tidak dilakukan	KTD	Audit medis dan RCA oleh tim mutu
3	26/8/2025	menunggu follow up berkala pro rujuk, DPJP minta ruang biasa	KTD	Melakukan komunikasi dengan DPJP bilamana pasien memang memerlukan ruang ICU, sebaiknya tetap di rawat di ruang ICU.
4	18/8/2025	dr. IGD tidak mengkaji adanya abd. Distendended	KTD	Dokter IGD harus mampu melakukan pengkajian dan pemeriksaan secara menyeluruh supaya dapat menentukan diagnosa dan menetapkan DPJP dengan sesuai.
5	18/8/2025	pro rujuk eksisi tumor, DPJP ACC ruang biasa	KTD	Melakukan komunikasi dengan DPJP supaya DPJP tidak takut untuk melakukan perawatan dan menetapkan ruang perawatan pasien sesuai kebutuhan pasien
6	16/8/2025	data tidak lengkap saat perawatan	KTD	seluruh petugas kesehatan wajib menulis apa yang sudah dilakukan kepada pasien dan wajib pula melakukan tindakan yang sudah di tulis pada rekam medis
7	13/8/2025	beberapa data tidak sesuai, pengkajian nyeri tidak di tulis	KTC	Audit medis dan RCA oleh tim mutu
9	5/8/2025	Lantai basah tetapi tidak ada tanda risiko jatuh	KPC	Segera melaporkan pada tim CS
10	7/8/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell
11	7/8/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Segera melaporkan pada IPSRS atau Tim IT

12	12/8/2025	Kesalahan penyiapan obat	KNC	Meningkatkan fokus dan ketelitian saat bekerja, melakukan double cek saat menyiapkan obat
13	15/8/2025	Kesalahan penyiapan obat	KNC	Meningkatkan fokus dan ketelitian saat bekerja, melakukan double cek saat menyiapkan obat
14	21/8/2025	Kesalahan penyiapan obat	KNC	Meningkatkan fokus dan ketelitian saat bekerja, melakukan double cek saat menyiapkan obat
15	22/8/2025	Kesalahan penyiapan obat	KNC	Meningkatkan fokus dan ketelitian saat bekerja, melakukan double cek saat menyiapkan obat
16	22/8/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
17	27/8/2025	Lantai basah tetapi tidak ada tanda risiko jatuh	KPC	segera melaporkan pada tim CS

September

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	21/9/2025	Tetanus di appendectomo	Sentinel	Audit medis dan RCA oleh tim mutu
2	23/9/2025	salah copas terapi	KNC	Audit medis dan RCA oleh tim mutu
3	22/9/2025	salah penilaian kegawatan	KTD	Audit medis dan RCA oleh tim mutu
4	21/9/2025	Dobutamin salah obat	KTD	Audit medis dan RCA oleh tim mutu
5	8/9/2025	syok sepsis	Sentinel	Audit medis dan RCA oleh tim mutu
6	9/9/2025	susp Ca Ovai, konsum ke IPD	KTD	A
7	3/9/2025	Kesalahan penyiapan obat	KNC	Audit medis dan RCA oleh tim mutu
9	4/9/2025	Kesalahan penyiapan obat	KNC	Audit medis dan RCA oleh tim mutu
10	7/9/2025	Kesalahan penyiapan obat	KNC	Meningkatkan fokus dan ketelitian saat bekerja, melakukan double cek saat menyiapkan obat
11	9/9/2025	Kesalahan penyiapan obat	KNC	Meningkatkan fokus dan ketelitian saat bekerja, melakukan double cek saat menyiapkan obat
12	11/9/2025	Lantai basah area ruang tunggu farmasi	KPC	segera melaporkan pada tim CS
13	13/9/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
14	14/9/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
15	20/9/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell
16	20/9/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP

17	22/9/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell
18	22/9/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Segera melaporkan pada IPSRS atau Tim IT
19	22/9/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
20	24/9/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
21	25/9/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
22	27/9/2025	Lantai basah tetapi tidak ada tanda risiko jatuh	KPC	segera melaporkan pada tim CS

Oktober

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	2/10/2025	Kesalahan penyian obat	KPC	- Implementasi <i>double check</i> - Audit e-resep secara berkala.
2	3/10/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Koordinasi dengan bagian IT atau IPSRS
3	5/10/2025	Kesalahan penyiapan obat	KPC	- Implementasi <i>double check</i> - Audit e-resep secara berkala.
4	6/10/2025	Lantai basah tanpa penanda risiko jatuh	KPC	Segera menghubungi tim CS rumah sakit supaya segera mengepel lantai dengan memasang tanda risiko jatuh
5	7/10/2025	Kesalahan input e-resep	KNC	Penegasan tanggung jawab verifikasi DPJP sebelum finalisasi resep.
6	8/10/2025	Kejadian lift eror	KPC	Pemeriksaan rutin dan <i>preventive maintenance</i> lift.
7	9/10/2025	Kesalahan penyiapan obat	KPC	- Implementasi <i>double check</i> - Audit e-resep secara berkala.
8	13-10-2025	Kekurangan petugas pada unit IGD	KPC	- Penyesuaian jadwal dinas sesuai kebutuhan pasien. - Evaluasi kebutuhan SDM tambahan di IGD.
9	15-10-2025	Kesalahan pemberian obat	KTD	Implementasi <i>double check</i> sebelum pemberian obat.
10	18-10-2025	Ketidaktepatan penetapan DPJP	KTD	Sosialisasi prosedur penetapan DPJP.
11	18-10-2025	Kesalahan penyiapan obat	KPC	- Implementasi <i>double check</i> - Audit e-resep secara berkala.
12	19-10-2025	Pasien IGD tidak terpasang handrel	KPC	- Supervisi rutin oleh kepala ruang IGD - Monitoring pemasangan handrail setiap shift.
13	20-10-2025	DPJP salah input e-resep	KNC	Penegasan tanggung jawab verifikasi DPJP sebelum finalisasi resep.
14	21-10-2025	Kesalahan penyiapan obat	KPC	- Implementasi <i>double check</i> - Audit e-resep secara berkala.
15	22-10-2025	Kesalahan penyiapan obat	KPC	- Implementasi <i>double check</i> sebelum pemberian obat. - Audit e-resep secara berkala.

16	23-10-2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	- Supervisi rutin oleh kepala ruang IGD.
				- Penempelan label risiko jatuh pada bed pasien.
				- Monitoring pemasangan handrail setiap shift.
17	24-10-2025	IGD tidak melakukan pengkajian dengan lengkap sehingga Riwayat obat yang diminum pasien tidak terkaji	KNC	- Reorientasi pengkajian awal sesuai format asesmen awal keperawatan.
				- Supervisi rutin oleh kepala ruang IGD.
				- Monitoring audit dokumentasi pasien IGD.
18	25-10-2025	Kesalahan penyiapan obat	KPC	- Implementasi <i>double check</i>
				- Audit e-resep secara berkala.
19	26-10-2025	Ditemukan benda asing (ulat) dalam makanan pasien	KTC	- Penguatan pengawasan dan inspeksi makanan sebelum distribusi.
				- Audit kebersihan dapur dan alat masak
				- Edukasi ulang petugas gizi terkait <i>food hygiene</i> .
20	27-10-2025	Kesalahan pemberian diet	KTC	- Cross check antara order diet dan label makanan.
				- Verifikasi oleh petugas gizi sebelum distribusi.
21	28-10-2025	Kesalahan pemberian diet	KTC	- Cross check antara order diet dan label makanan.
				- Verifikasi oleh petugas gizi sebelum distribusi.
22	29-10-2025	DPJP salah input e-serep	KNC	Penegasan tanggung jawab verifikasi DPJP sebelum finalisasi resep.
23	30-10-2025	Pasien harus menjalani operasi ulang karena saat foto post operasi tampak wire yang terlalu Panjang (dr. Kuntadi)	KTD	- Audit medis kasus.
				- Pembahasan dalam komite medik.
24	30-10-2025	Kesalahan pemberian diet	KTC	- Cross check antara order diet dan label makanan.
				- Verifikasi oleh petugas gizi sebelum distribusi.
25	30-10-2025	Kesalahan pemberian diet	KTC	- Cross check antara order diet dan label makanan.
				- Verifikasi oleh petugas gizi sebelum distribusi.
26	31-10-2025	Kesalahan pemberian diet	KTC	- Cross check antara order diet dan label makanan.
				- Verifikasi oleh petugas gizi sebelum distribusi.

November

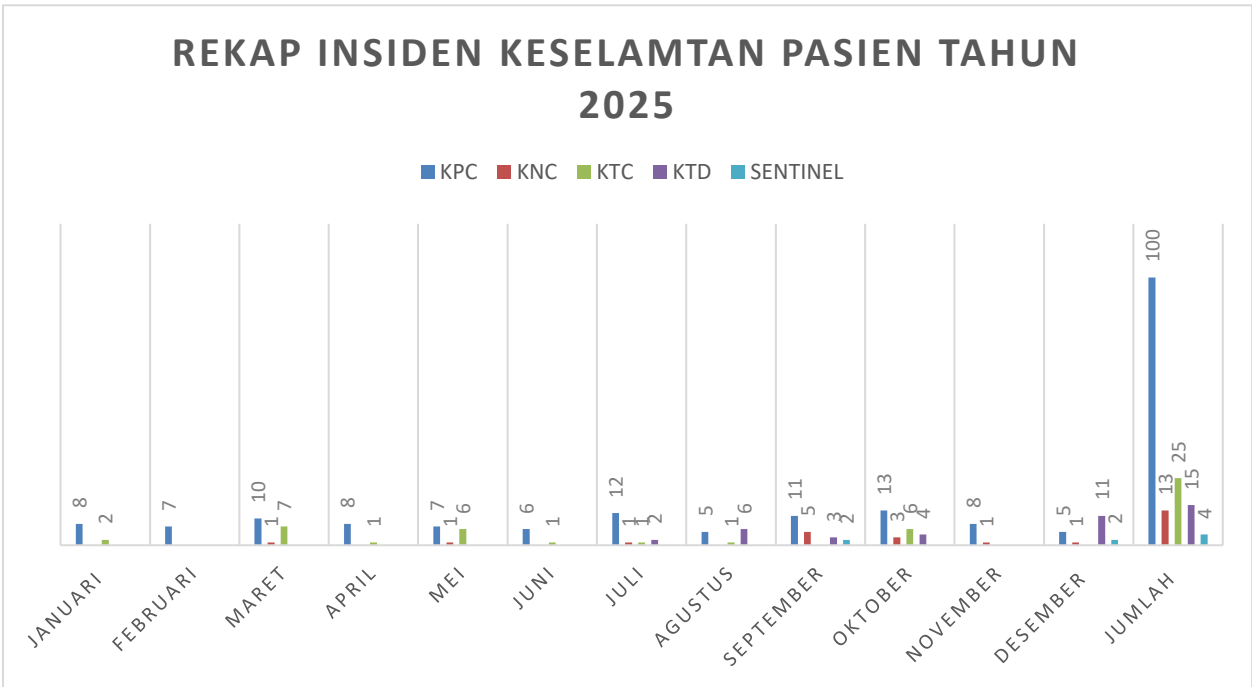
No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	1/11/2025	Kesalahan input e-resep	KNC	- Segera konfirmasi DPJP untuk memastikan resep yang benar - Penegasan tanggung jawab verifikasi DPJP sebelum finalisasi resep.
2	1/11/2025	Kesalahan penyiapan obat	KPC	Implementasi <i>double check</i>
3	11/11/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Koordinasi dengan bagian IT atau IPSRS
4	14/11/2025	Lantai basah di pintu masuk poli	KPC	Segera menghubungi tim CS rumah sakit supaya segera mengepel lantai dengan memasang tanda risiko jatuh
5	19/11/2025	Kabel tidak rapi yang bisa menyebabkan risiko jatuh	KPC	Koordinasi dengan bagian IT atau IPSRS
6	22/11/2025	Tumpahan di ruangan pasien (IGD) yang dapat menyebabkan risiko terpeleset	KPC	Segera menghubungi tim CS rumah sakit supaya segera mengepel lantai dengan memasang tanda risiko jatuh
7	26/11/2025	Tumpahan di ruangan pasien (5C) yang dapat menyebabkan risiko terpeleset	KPC	Segera menghubungi tim CS rumah sakit supaya segera mengepel lantai dengan memasang tanda risiko jatuh
8	27/11/2025	Tumpahan di ruangan pasien (8A) yang dapat menyebabkan risiko terpeleset	KPC	Segera menghubungi tim CS rumah sakit supaya segera mengepel lantai dengan memasang tanda risiko jatuh
9	27/11/2025	Tumpahan di ruangan pasien (3C) yang dapat menyebabkan risiko terpeleset	KPC	Segera menghubungi tim CS rumah sakit supaya segera mengepel lantai dengan memasang tanda risiko jatuh

Desember

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Tindak Lanjut
1	4/12/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
2	7/12/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
3	9/12/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell
4	12/12/2025	Tulisan DPJP di rekam medis yang tidak terbaca	KPC	Melaporkan pada sekre komdik untuk membantu mengingatkan DPJP
5	16/12/2025	Pasien IGD tidak terpasang handrell	KPC	Mengingatkan secara langsung perawat yang sedang bertugas dan membantu memberikan KIE kepada pasien tentang pentingnya pemasangan handrell
6	16/12/2025	kesalahan penulisan e-tiket obat	KNC	Jalin komunikasi baik dengan dokter penulis resep untuk mengingatkan DPJP, Apoteker wajib melakukan skrining dan verifikasi resep elektronik secara teliti.
7	17/12/2025	kesalahan hasil radiologi (tertukar)	KTD	lakukan identifikasi pasien sesuai SPO

REKAP IKP TAHUN 2025

	KPC	KNC	KTC	KTD	SENTINEL	JUMLAH
JANUARI	8		2			10
FEBRUARI	7					7
MARET	10	1	7			18
APRIL	8		1			9
MEI	7	1	6			14
JUNI	6		1			7
JULI	12	1	1	2		16
AGUSTUS	5		1	6		12
SEPTEMBER	11	5		3	2	21
OKTOBER	13	3	6	4		26
NOVEMBER	8	1				9
DESEMBER	5	1		11	2	19
JUMLAH	100	13	25	15	4	157



Analisa

Berdasarkan hasil rekapitulasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP) selama tahun 2025, tercatat total 157 kejadian yang terdiri dari berbagai kategori insiden, yaitu Kejadian Potensial Cedera (KPC) sebanyak 100 kasus (63,7%), Kejadian Tidak Cedera (KTC) sebanyak 25 kasus (15,9%), Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) sebanyak 15 kasus (9,6%), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sebanyak 13 kasus (8,3%), serta kejadian sentinel sebanyak 4 kasus (2,5%). Secara umum, data menunjukkan bahwa mayoritas insiden yang dilaporkan merupakan KPC. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya pelaporan insiden di rumah sakit sudah berjalan cukup baik, dimana petugas mampu mengidentifikasi potensi risiko sebelum menimbulkan dampak cedera pada pasien. Namun demikian, masih ditemukan kejadian dengan dampak serius seperti KTD dan sentinel yang memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan tren bulanan, kejadian IKP tertinggi terjadi pada bulan Oktober (26 kasus), diikuti September (21 kasus), Desember (19 kasus), dan Maret (18 kasus). Sementara itu, kejadian terendah tercatat pada bulan Februari dan Juni masing-masing sebanyak 7 kasus. Pola ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan insiden pada triwulan III dan IV, yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan beban kerja, kepadatan pasien, serta faktor kelelahan petugas.

Jika ditinjau berdasarkan jenis insiden, KPC mendominasi hampir di seluruh bulan, dengan angka tertinggi pada bulan Oktober. Kejadian KTD menunjukkan peningkatan signifikan pada bulan Desember, yang menandakan adanya insiden yang telah berdampak langsung terhadap pasien. Selain itu, kejadian sentinel ditemukan pada bulan September dan Desember, yang merupakan kejadian serius dan memerlukan dilakukan analisis akar masalah (Root Cause Analysis/RCA) secara komprehensif.

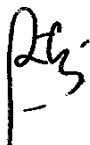
Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pelaporan insiden telah berjalan, namun pengendalian risiko masih perlu ditingkatkan untuk menurunkan kejadian yang berdampak terhadap pasien. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kepatuhan terhadap standar prosedur operasional, penguatan budaya keselamatan pasien, serta optimalisasi manajemen risiko terutama pada periode dengan tren peningkatan kejadian.

BAB III
PENUTUP

Demikian laporan Insiden Keselamatan Rumah Sakit Prima Husada Malang tahun 2025. Upaya yang dilakukan adalah upaya maksimal yang bisa dilakukan saat ini, terutama upaya angka kejadian KTD / KTC / KNC / KPC / Sentinel dapat ditekan dan kejadian serupa tidak akan terulang Kembali, baik di tempat / unit yang sama maupun di tempat / unit yang lain di rumah sakit Prima Husada Malang, sehingga dapat meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien dan lebih utama lagi terlaksananya asuhan pasien yang lebih aman.

Malang, 03 Januari 2025

Ketua Komite PMKP
RS Prima Husada Malang,



dr. Ari Putriani, Sp. PK

PLT Direktur
RS Prima Husada Malang,



dr. Resti Lestantini, M.Kes